

Respostas do Adriano

1. O CLIENTE E O SEU MUNDO

Primeira:

“””

Olha, prazer falar com vocês. Eu sou o Adriano Matos, tenho 47 anos, sou administrador de formação e trabalho há muitos anos com organizações da saúde e do cuidado aqui no Maranhão. A AM Consultoria nasceu em 2014, muito a partir da prática mesmo, de estar dentro dessas instituições e ver que muita coisa não era falta de boa vontade — era falta de organização, de processo, de clareza. Na prática, o que eu faço é entrar nessas organizações, entender como elas funcionam de verdade — não no papel, mas no dia a dia — e ajudar a organizar a casa. Isso passa por diagnóstico, ajustar rotina, orientar equipe, e depois acompanhar pra ver se as mudanças estão funcionando.

Hoje eu atendo sete clientes ao mesmo tempo. Tem desde uma instituição de longa permanência para idosos, até CAPS, creche, clínica de reabilitação... cada um com uma realidade completamente diferente. E aí é que começa meu problema. Eu ajudo eles a se organizarem, mas a minha própria operação virou um emaranhado. Semana passada mesmo, um cliente me ligou perguntando quando seria a próxima visita. Eu não soube responder. Tive que caçar no WhatsApp, em conversa antiga, e levei quase vinte minutos pra achar. Isso passa uma imagem ruim, entende? Parece desorganização — e é mesmo.

Outro exemplo bem concreto: esses dias eu tinha dois relatórios importantes pra entregar, um para o Lar São Francisco e outro para a APAE de Bacabal, no mesmo dia. Eu só me dei conta disso quando já estava em cima da hora. Não foi falta de trabalhar, foi falta de visão do todo. Está tudo espalhado — um pouco em planilha, um pouco em caderno, um pouco na cabeça. E como minha assistente saiu há dois meses, piorou muito. Eu estou operando sozinho algo que já não é mais pequeno.

E por que isso é crítico na economia do cuidado? Veja bem, quando a gente fala de uma loja, atrasar um processo é ruim. Mas quando você está lidando com idosos, crianças, pacientes em sofrimento mental... qualquer desorganização impacta diretamente na qualidade do cuidado. Se eu esqueço um ponto importante de uma visita anterior no CAPS, por exemplo, posso deixar de orientar algo que afeta o atendimento de dezenas de pessoas. Então o meu trabalho precisa ser muito bem amarrado. Não é só eficiência — é responsabilidade mesmo.

“””

Segunda:

“”””

Olha, vamos lá. Eu sou o Adriano Matos, sou administrador de formação e há mais de 10 anos eu trabalho exclusivamente com organizações da área de cuidado — saúde, assistência, educação especial... esse tipo de serviço que lida diretamente com gente, com vida real. A minha consultoria, a AM Consultoria, entra dentro dessas instituições pra organizar a casa. Na prática, eu passo semanas dentro do cliente entendendo como eles funcionam, onde estão os gargalos, proponho melhorias e depois acompanho se aquilo tá funcionando.

No meu dia a dia, eu tô indo de um cliente pra outro, fazendo reunião com gestor, conversando com equipe, olhando processo, anotando tudo em caderno, trocando mensagem no WhatsApp... e depois preciso transformar isso em relatório, em plano de ação, em acompanhamento. Só que veja bem: eu cresci. Hoje são sete clientes ao mesmo tempo. E eu continuo trabalhando como se fosse quando eu tinha dois.

O problema real, e aqui eu falo sem rodeio, é que eu perdi o controle da minha própria operação. Na semana passada, um cliente me ligou perguntando quando seria a próxima visita. Eu não soube responder. Tive que abrir conversa, procurar mensagem antiga, áudio... levei quase 20 minutos. Já aconteceu de eu ter dois relatórios importantes pra entregar no mesmo dia e só perceber quando já estava em cima da hora. E tem outra coisa: cada cliente me paga de um jeito diferente. Quando chega no fim do mês, eu passo horas tentando entender quanto cada um me deve. Isso não é sustentável, não é profissional — e começa a afetar a qualidade do meu trabalho.

Agora, por que isso importa num contexto maior? Porque eu não atendo qualquer negócio. Eu atendo creche, CAPS, ILPI, APAE... organizações que já operam no limite. O Maranhão, por exemplo, está envelhecendo rápido — isso eu vejo na prática, não é só número. Se eu falho em organizar o Lar São Francisco, quem sofre é o idoso lá dentro. Se eu não acompanho direito o CAPS, impacta o cuidado em saúde mental. Ou seja, a desorganização da minha consultoria acaba respingando diretamente em quem já está vulnerável. Não é só um problema meu, entende?

Deixa eu te dar uma situação bem concreta. Teve um dia que eu fui pro CAPS II Renascer. Cheguei lá, cumprimentei o Dr. Augusto... e me deu um branco. Eu não lembrava exatamente o

que tinha ficado pendente da última visita. E no CAPS isso é grave, porque eles acompanham quase 300 usuários, cada um com um plano de cuidado diferente. Eu tive que, antes de entrar, ligar pro próprio Dr. Augusto pra perguntar: “Doutor, o que foi que a gente combinou da última vez mesmo?”. Na prática, eu perdi autoridade ali como consultor.

Então é isso que eu quero que vocês entendam: não é só “organizar agenda” ou “guardar informação”. É me dar condição de trabalhar com clareza, acompanhar sete realidades complexas ao mesmo tempo e não deixar nada importante se perder no caminho. Agora me diga uma coisa — quando vocês pensam numa solução, o que exatamente vocês precisam saber do meu trabalho pra conseguir me ajudar de verdade?

“”””

2. O QUE O GRUPO DESCOBRIU

Primeira:

“”””

Olha, essa pergunta de vocês é muito boa, porque tem coisa no meu trabalho que, de fora, parece simples... mas quando você entra, vê que não é bem assim.

Primeiro ponto: cada cliente meu funciona de um jeito completamente diferente. E não é só na operação deles, é na forma como eu me relaciono com eles também. Tem cliente que me paga por visita, tem outro que é mensal, tem outro que é por projeto fechado. Aí, no fim do mês, eu tenho que parar e praticamente “reconstruir” tudo que eu fiz pra entender quanto cada um me deve. Não é automático. Eu vou lembrando: “essa visita aqui foi extra”, “essa aqui já estava incluída”... e nem sempre isso está claro nem pra mim. Já teve mês que eu fiquei na dúvida se devia cobrar ou não uma visita que fiz meio como urgência.

E aí entra uma coisa que costuma surpreender quem tenta entender meu trabalho: nem toda visita é igual — mas, na prática, eu registro tudo como se fosse. Às vezes eu vou numa instituição só pra resolver um problema pontual, coisa rápida. Às vezes é uma visita estruturada, com roteiro, diagnóstico, reunião com equipe. E às vezes é quase uma intervenção de crise. Só que no meu caderno... é tudo “visita”. Não tem muita diferenciação. Aí depois, quando eu olho pra trás, eu mesmo fico sem entender direito o que foi feito em cada ida.

Outra coisa que é mais complexa do que parece é essa questão de quem fala comigo em cada cliente. Não existe uma pessoa só. No CAPS, por exemplo, o principal é o Dr. Augusto, mas quem me chama no dia a dia muitas vezes é a assistente social. No Lar São Francisco, é a

Conceição, mas quando envolve dinheiro, quem resolve é a filha dela. Então assim... dependendo do assunto, muda a pessoa. E isso não está organizado em lugar nenhum — está tudo na minha cabeça e no histórico de conversa.

E tem uma ambiguidade grande também nos relatórios. Em alguns contratos, o relatório já está incluído. Em outros, eu cobro à parte. E tem situações em que o cliente pede algo fora do previsto... e eu fico naquele meio-termo: “isso aqui é parte do meu trabalho ou é um extra?”. Hoje, como é que eu resolvo isso? Na conversa. No bom senso. Às vezes eu cobro, às vezes eu não cobro... mas isso vai criando uma inconsistência, sabe?

Pra vocês entenderem bem: meu trabalho não é padronizado. Ele é muito adaptado à realidade de cada cliente. Só que essa flexibilidade, que é o que dá valor pro serviço, é exatamente o que está me bagunçando por dentro.

“””

Segunda:

“””

Olha, quando a gente começou a conversar aqui, pode até parecer que o meu problema é só “falta de organização”. Mas na prática, tem umas camadas que não aparecem de primeira. Uma coisa que foi ficando clara pra mim com o tempo é que cada cliente meu funciona de um jeito completamente diferente — não é só mudar o nome. O CAPS, por exemplo, não fala nem a mesma língua que uma clínica ou uma creche. Lá não é “paciente”, é “usuário”, não é “consulta”, é “atendimento”. Já na CuidaBem, é escala de cuidador, troca de plantão, família ligando de madrugada... são lógicas muito diferentes convivendo dentro da minha rotina. Isso foi me surpreendendo, porque eu percebi que não é um problema único — são vários mundos que eu tento controlar do mesmo jeito.

Outra coisa que complica muito, e talvez vocês não vejam de cara, é que meu trabalho não é padronizado. Veja bem: uma visita não é sempre igual. Às vezes eu vou num cliente fazer um diagnóstico mais profundo, passo o dia inteiro lá. Às vezes é uma visita rápida, só pra resolver uma urgência. E no meu caderno... fica tudo igual. “Visita realizada”. Só que não são a mesma coisa. Isso dificulta demais depois, quando eu preciso lembrar o que foi feito, o que ficou pendente, ou até justificar o que eu cobre. E tem também os relatórios — tem cliente que já pagou por aquilo no contrato, tem cliente que eu cobro à parte... e isso nunca tá claro no registro.

Agora, se você me pergunta o que mais atrapalha organizar isso tudo... eu diria que é justamente essa mistura de formal com informal. Tem coisa que eu registro direitinho numa planilha, mas tem muita coisa importante que tá em áudio de WhatsApp, em conversa, em memória. Já cheguei numa visita sem lembrar do que tinha sido combinado antes. E tem outro ponto: eu não tenho uma linha clara de quem é o responsável em cada cliente. Às vezes é uma pessoa, às vezes é outra... no CAPS, por exemplo, quem fala comigo é o Dr. Augusto, mas direto aparece outra pessoa da equipe com demanda. No Lar, a diretora resolve uma coisa, mas a parte financeira é com outra pessoa da família. Isso vai embaralhando tudo.

E aí entra a ambiguidade maior, que eu mesmo não sei responder direito. O que é exatamente uma “visita” no meu trabalho? Porque, na prática, pode ser muita coisa diferente. Pode ser uma reunião, pode ser uma intervenção, pode ser um acompanhamento, pode ser uma crise. Hoje eu trato tudo igual — mas não é igual. E eu não sei se o caminho é separar isso ou manter junto e só detalhar melhor.

Se vocês forem pensar em como organizar isso, eu imagino que teria dois caminhos... ou vocês tentam “forçar” um padrão — o que eu tenho medo de não caber na realidade — ou criam alguma forma de registrar essas variações sem perder a simplicidade. Porque, olha, se ficar complicado demais, eu mesmo não vou usar.

Agora me diz uma coisa: pra vocês conseguirem me ajudar, vocês precisam que eu defina exatamente o que é cada tipo de visita... ou dá pra trabalhar com essa bagunça organizada que é a vida real?

“””

3. CONEXÃO COM A ECONOMIA DO CUIDADO

“””

Olha, essa pergunta de vocês é muito boa, porque toca num ponto que eu vivo no dia a dia, mas nem sempre paro pra estruturar assim. Quando a gente fala de Economia do Cuidado, a gente tá falando de tudo aquilo que sustenta a vida — criança, idoso, pessoa com deficiência, saúde mental... e todos os meus clientes estão exatamente aí. Então veja bem: o meu trabalho não é direto com o paciente, com o aluno ou com o idoso, mas ele influencia como esse cuidado acontece. Se eu organizo melhor uma creche, eu tô ajudando aquela mãe que precisa trabalhar tranquila. Se eu melhora um CAPS, eu tô contribuindo pra que uma pessoa em sofrimento psíquico não seja abandonada.

Na prática, eu costumo dizer que eu cuido de quem cuida. Só que hoje, com a minha desorganização, esse cuidado fica comprometido. Porque quando eu esqueço uma pendência, atraso um relatório ou deixo de acompanhar um processo, eu não tô só falhando com o gestor — eu tô afetando uma cadeia inteira de cuidado. E isso é muito sério num estado como o Maranhão, que já tem uma estrutura mais frágil e uma demanda crescente. O IBGE mesmo mostra que a população idosa tá aumentando rápido por aqui... e a gente não tem sistema preparado pra isso.

Sobre impacto social, eu vejo claramente que não sou só eu que sofro com esse problema. Tem os meus clientes, que ficam sem o acompanhamento adequado. Tem as equipes deles, que deixam de implementar melhorias porque eu não consegui organizar o que foi combinado. E no final da ponta estão as pessoas mais vulneráveis: o idoso no Lar São Francisco, a criança da creche, o usuário do CAPS, a família que depende de um cuidador em casa. Às vezes é uma coisa pequena — um ajuste de processo que não foi feito — mas que muda completamente a qualidade do atendimento.

Agora, quando vocês falam de desenvolvimento, inovação e sustentabilidade... eu vejo isso de forma bem concreta. Se eu conseguir me organizar melhor, eu consigo atender mais clientes sem perder qualidade — isso é desenvolvimento. Se eu tiver uma forma de registrar e acompanhar tudo isso de maneira mais inteligente, sem depender de caderno e memória, isso já é uma inovação enorme pra minha realidade. E sustentabilidade, pra mim, é conseguir manter esse trabalho no longo prazo sem entrar em colapso. Porque hoje, sendo bem sincero, eu tô perto do limite.

E por que isso é urgente hoje? Porque a sociedade tá mudando rápido. As famílias estão menores, as pessoas vivem mais, tem mais gente precisando de cuidado fora de casa. E essas organizações — creche, CAPS, home care, APAE — estão crescendo, mas muitas ainda funcionam no improviso. Eu sou chamado justamente pra ajudar nisso... só que agora eu virei o gargalo.

Então eu devolvo pra vocês uma provocação: vocês acham que resolver o meu problema ajuda só a minha consultoria... ou pode virar um modelo que sirva pra outras organizações do cuidado que estão vivendo esse mesmo caos, só que por dentro?

“”””

Detalhamento dos Clientes

1. 🧩 Detalhamento dos CLIENTES (essencial)

Você já percebeu isso — mas precisa transformar em dados:

Perguntar:

- Quais informações você precisa guardar sobre cada cliente?
- O que diferencia um cliente do outro na prática?
- Existe contrato formal? O que ele define?
- Como funciona pagamento (valor, tipo, frequência)?

👉 Aqui você descobre entidades como:

Cliente, Contrato, Tipo de cliente

CLIENTES:

“”””

1. Lar São Francisco
2. Creche Sonho de Criança
3. CAPS II Renascer
4. CuidaBem
5. REABILITA
6. APAE de Bacabal
7. FarmaVida

“”””

“”””

Olha, essa pergunta de vocês já começa a entrar bem no coração do meu problema. Porque hoje eu até tenho essas informações... só que estão espalhadas, cada uma num lugar. Se eu pudesse abrir alguma coisa e ver tudo de um cliente de forma organizada, já resolveria metade da minha dor.

Sobre o básico que vocês falaram, tudo isso faz sentido sim: nome da instituição, tipo — se é CAPS, creche, ILPI — localização, quem é o responsável, contatos... isso tudo eu uso. Mas, na prática, eu preciso de mais coisa. Por exemplo, eu sempre quero lembrar quando comecei com

aquele cliente, porque isso me ajuda a entender em que fase ele está. Também preciso saber quem são as outras pessoas envolvidas — porque raramente é só um contato. No Lar São Francisco, por exemplo, eu falo com a Conceição no dia a dia, mas quando o assunto é dinheiro, é outra pessoa da família. Se eu não tiver isso claro, eu me perco.

Outra coisa importante é o “histórico” daquele cliente comigo. O que eu já fiz lá? Teve diagnóstico? Já entreguei relatório? O que ficou pendente? Hoje isso tá em pedaços — caderno, áudio, memória. Eu queria bater o olho e entender rapidamente: “esse cliente tá em que situação comigo?”. Porque às vezes eu chego numa visita meio no escuro, tentando lembrar na cabeça.

Agora, sobre as diferenças entre os clientes... veja bem, isso aqui é onde complica de verdade. O meu trabalho muda muito de um pra outro. Vou te dar dois exemplos bem claros. O CAPS II Renascer é um serviço público, com muita gente envolvida, decisões coletivas... lá eu faço mais acompanhamento de processo, participo de reunião, discuto fluxo de atendimento. Já na CuidaBem, que é home care, o problema é operacional: escala de cuidador, troca de plantão, urgência de família. Lá eu sou quase um “apagador de incêndio” às vezes.

A frequência também muda. Tem cliente que eu vou toda semana, tem cliente que é uma vez por mês... e às vezes tem visita fora do combinado, quando dá problema. E o nível de complexidade varia muito. A APAE de Bacabal, por exemplo, tem saúde, educação e assistência social tudo misturado — é outro nível de complexidade. Já a FarmaVida é mais focada, mas tem aquela exigência rígida do governo. Então não dá pra tratar tudo igual.

Sobre contrato... aí entra outra bagunça organizada. Eu tenho contrato com todos, sim, mas nem todos são iguais. Alguns são mais formais, assinados, bonitinhos. Outros começaram mais no “vamos começar e depois ajusta”. Normalmente eu defino o tipo de serviço, mais ou menos quantas visitas, se tem relatório... mas isso muda ao longo do tempo. Já teve cliente que começou com um escopo pequeno e hoje me demanda muito mais. E eu nem sempre atualizo isso direito.

Pagamento então... cada um é de um jeito. Tem cliente que me paga mensal fixo, independente de quantas visitas eu vá. Tem outros que pagam por visita. Tem projeto fechado também. E tem os “extras” — uma visita urgente, um relatório fora do combinado... que às vezes eu cobro, às vezes deixo passar. No fim do mês, eu fico juntando tudo: “fui tantas vezes aqui, esse aqui é mensal, esse aqui teve extra...” é um sofrimento. Eu não tenho um controle claro, é muito manual.

Agora, sobre classificar os clientes... faz sentido sim, mas eu nunca consegui fazer isso de forma organizada. Na minha cabeça, eu separo meio que assim: por tipo de instituição, porque isso muda muito a lógica; por forma de pagamento, porque impacta direto no meu financeiro; e também por nível de complexidade — tem cliente que exige muito mais acompanhamento que outro. Mas isso tá tudo na minha cabeça.

Se eu pudesse ter uma coisa só pra cada cliente e abrir e ver tudo isso — quem é, como eu me relaciono, quanto paga, o que já fiz, o que falta — já seria um ganho enorme. Agora me diga: vocês estão pensando em algo mais “engessado”, tudo bem definido... ou algo mais flexível, que aceite essa bagunça do mundo real? Porque isso, pra mim, faz toda diferença.

“””

“””

Olha... eu vou tentar te ajudar do jeito que você pediu, mas já vou te dizer: isso aqui pra mim não é natural, não. Vocês estão puxando pro lado mais estruturado, e eu penso muito mais na prática do dia a dia. Então, se tiver coisa que parecer meio “solta”, é porque na minha cabeça também é assim.

1. DADOS DE UM CLIENTE (estrutura completa)

Nome do campo: Nome da instituição

O que é: Nome oficial do cliente

Exemplo: Lar São Francisco

Nome do campo: Tipo de instituição

O que é: Área de atuação do cliente

Exemplo: ILPI (instituição de longa permanência para idosos)

Nome do campo: Cidade

O que é: Onde o cliente está localizado

Exemplo: São Luís

Nome do campo: Responsável principal

O que é: Pessoa que fala comigo no dia a dia

Exemplo: Conceição (diretora do Lar)

Nome do campo: Outros contatos

O que é: Outras pessoas que também entram em contato

Exemplo: Filha da Conceição (financeiro), enfermeira chefe

Nome do campo: Telefone/WhatsApp

O que é: Forma de contato direto

Exemplo: (98) 9xxxx-xxxx

Nome do campo: Data de início do contrato

O que é: Quando comecei a atender o cliente

Exemplo: 10/03/2024

Nome do campo: Status do cliente

O que é: Situação atual do contrato

Exemplo: Ativo

Nome do campo: Nível de complexidade

O que é: O quanto o cliente demanda esforço

Exemplo: Alto (CAPS), Médio (clínica), Variável (home care)

Nome do campo: Frequência de visitas

O que é: Com que frequência eu vou até o cliente

Exemplo: 1 vez por semana

Nome do campo: Local de atendimento

O que é: Onde acontece o serviço

Exemplo: Presencial no cliente / às vezes remoto

Nome do campo: Tipo de serviço prestado

O que é: O que eu faço para aquele cliente

Exemplo: Diagnóstico + acompanhamento

Nome do campo: Observações gerais

O que é: Informações importantes que não cabem nos outros campos

Exemplo: “Diretora centraliza decisões, financeiro é separado”

2. 🌱 DIFERENÇAS ENTRE CLIENTES (ESTRUTURADO)

O que varia: Tipo de instituição

Possíveis valores: ILPI, CAPS, creche, clínica, home care, APAE, farmácia

Exemplo: CAPS II Renascer = CAPS

O que varia: Forma de pagamento

Possíveis valores: mensal, por visita, por projeto

Exemplo: CuidaBem = por visita / APAE Bacabal = mensal

O que varia: Frequência de visitas

Possíveis valores: semanal, quinzenal, mensal, sob demanda

Exemplo: Lar São Francisco = semanal

O que varia: Nível de complexidade

Possíveis valores: baixo, médio, alto

Exemplo: CAPS = alto

O que varia: Tipo de entrega

Possíveis valores: relatório, reunião, orientação verbal

Exemplo: REABILITA = relatório + acompanhamento

O que varia: Quantidade de contatos

Possíveis valores: 1, vários

Exemplo: Creche = diretora + secretária

3. CONTRATO (DETALHADO COMO DADOS)

Tipo de contrato

Exemplo: Mensal com acompanhamento contínuo (APAE)

Quantidade de visitas previstas

Exemplo: 4 por mês (Lar São Francisco)

Inclui relatório?

Exemplo: Depende — Lar inclui / outros cobram à parte

Data de início

Exemplo: 01/02/2024

Data de término

Exemplo: (às vezes não tem, fica em aberto)

Valor acordado

Exemplo: R\$ 3.000/mês

Pode ter alteração? Como isso acontece?

Exemplo: Sim — geralmente por conversa no WhatsApp ou reunião

“Adriano, vamos reduzir visitas esse mês?”

Inclui visitas extras?

Exemplo: Às vezes sim, mas nem sempre está claro se cobra

Observação do contrato

Exemplo: “Relatório só mediante solicitação”

4. 💰 PAGAMENTO (ESTRUTURA CLARA)

Tipo de cobrança

Exemplo: Mensal / por visita

Valor

Exemplo: R\$ 800 por visita

Frequência

Exemplo: Mensal ou conforme uso

Data de vencimento

Exemplo: Todo dia 10

Existe cobrança extra?

Exemplo: Sim — visitas extras ou relatórios adicionais

Como identificar cobrança extra?

Exemplo: Hoje é no “feeling” — eu lembro ou anoto no caderno

Como saber o que já foi pago?

Exemplo: Conferindo extrato bancário + conversa no WhatsApp

Exemplos reais:

Cliente: CuidaBem

Tipo de cobrança: por visita

Valor: varia por demanda

Frequência: irregular

Problema: difícil saber total do mês

Cliente: APAE Bacabal

Tipo de cobrança: mensal

Valor: fixo

Frequência: mensal

Problema: às vezes pedem coisas extras fora do combinado

5. 🧠 CLASSIFICAÇÃO DOS CLIENTES

Classificação: Tipo de instituição

Categorias: CAPS, ILPI, creche, clínica, home care, APAE, farmácia

Exemplo: FarmaVida = farmácia

Classificação: Nível de complexidade

Categorias: baixo, médio, alto

Exemplo: CAPS = alto

Classificação: Tipo de contrato

Categorias: mensal, por visita, por projeto

Exemplo: CuidaBem = por visita

Classificação: Situação do cliente

Categorias: ativo, pausado, encerrado

Exemplo: todos hoje = ativos

Classificação: Forma de atendimento

Categorias: presencial, remoto, híbrido

Exemplo: REABILITA = presencial

Agora deixa eu te dizer uma coisa com sinceridade... vocês estão organizando isso de um jeito bem certinho, né? Mas na prática, muita coisa aqui muda no meio do caminho.

Aí eu te pergunto: esse sistema que vocês estão pensando vai conseguir lidar com essas mudanças... ou ele vai me obrigar a trabalhar de um jeito que não é o da vida real?

“”””

Lar São Francisco

Nome da instituição:

Lar São Francisco

Tipo de instituição:

ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) privada com vagas conveniadas

Cidade:

São Luís, MA

Responsável principal:

Conceição Ribeiro, 51 anos, enfermeira e diretora

Outros contatos:

Filha da Conceição (administrativo/financeiro), equipe de enfermagem, médicos prestadores, nutricionista terceirizada

Telefone/WhatsApp:

(olha, não tenho anotado exatamente o número, mas a comunicação é via WhatsApp direto com a Conceição e grupo da equipe)

Data de início do contrato:

2018 (aproximadamente, antes de abrir a consultoria, mas seguimos com visitas regulares desde então)

Status do cliente:

Ativo

Nível de complexidade:

Alto — são 60 residentes com múltiplos processos médicos e administrativos, prontuários descentralizados, incidentes e contratos variados

Frequência de visitas:

Mensal (mas ocorrem emergências e visitas extras sob demanda)

Local de atendimento:

Presencial

Tipo de serviço prestado:

Diagnóstico organizacional, acompanhamento de processos de cuidado, relatórios periódicos, reuniões de equipe, orientação para regulatório e VISA

Observações gerais:

A instituição tem histórico de erros na administração de medicamentos, prontuário em papel espalhado entre profissionais, queda de residentes com registros inconsistentes. Responsável legal de alguns idosos muda dependendo do grau de dependência ou da família. Cada profissional usa método próprio de registro.

Tipo de contrato:

Mensal com valor fixo por residente e algumas visitas extras cobradas separadamente

Quantidade de visitas previstas:

1 visita mensal programada, mais visitas extras conforme necessidade

Inclui relatório?

Sim — relatórios trimestrais e anuais para VISA, além de entregas periódicas sobre residentes e incidentes

Data de término do contrato:

Indefinido, renovação automática mensal

Valor acordado / forma de pagamento:

R\$ 3.200 a R\$ 5.800 por residente/mês dependendo do grau de dependência (I, II ou III), pago via transferência bancária ou boleto mensal

Pode ter alteração? Como acontece?

Sim, ajustes ocorrem caso o número de residentes mude ou surja demanda extraordinária, negociados diretamente com a Conceição

Inclui visitas extras?

Sim, visitas emergenciais ou consultorias específicas fora do ciclo mensal são cobradas à parte

Como identificar cobrança extra:

Visitas fora do agendamento mensal padrão, projetos especiais ou acompanhamento de incidentes críticos

Como saber o que já foi pago:

Conferência via comprovantes bancários e registros em planilha de controle — ainda não automatizado, preciso revisar cada mês manualmente

Creche Sonho de Criança

Nome da instituição:

Creche Sonho de Criança

Tipo de instituição:

Creche comunitária conveniada com a prefeitura

Cidade:

São Luís, MA

Responsável principal:

Rosângela Teixeira, 44 anos, pedagoga e diretora

Outros contatos:

Secretária da creche, professoras, auxiliares de turma, cozinheiras, equipe administrativa (financeiro limitado à coordenação da Rosângela)

Telefone/WhatsApp:

Comunicação principal via WhatsApp com Rosângela e grupo da equipe

Data de início do contrato:

2019 — acompanhamento contínuo desde então

Status do cliente:

Ativo

Nível de complexidade:

Médio — alta demanda de prestação de contas para a prefeitura, frequência e alimentação precisam ser controladas manualmente, responsáveis legais das crianças mudam com frequência

Frequência de visitas:

Mensal, com possibilidade de visitas extras para auditoria ou ajustes de processo

Local de atendimento:

Presencial

Tipo de serviço prestado:

Diagnóstico de processos administrativos, acompanhamento de frequência e cardápio, reuniões com a coordenação, relatórios mensais para Prefeitura

Observações gerais:

O controle é todo manual: caderno de frequência por turma, quadro de cardápio, listas físicas para vacinação. Irmãos podem estar em turmas diferentes com registros separados. Qualquer mudança de turma ou ausência precisa ser conferida manualmente, o que gera retrabalho constante para a equipe

Tipo de contrato:

Mensal, baseado em acompanhamento contínuo e relatórios periódicos

Quantidade de visitas previstas:

1 visita mensal programada, mais visitas extras sob demanda

Inclui relatório?

Sim — relatório mensal de frequência, documentação de crianças, cardápio e vacinação

Data de término do contrato:

Indefinido, renovação automática mensal

Valor acordado / forma de pagamento:

R\$ 480 por criança/mês pago pela prefeitura via repasse à creche, consultoria paga com valor fixo mensal negociado com Rosângela

Pode ter alteração? Como acontece?

Sim, caso o número de crianças mude ou surja demanda extraordinária, é negociado diretamente com a Rosângela

Inclui visitas extras?

Sim, principalmente para auditorias ou ajustes de processo solicitados pela coordenação ou pela prefeitura

Como identificar cobrança extra:

Quando a visita não estava prevista no ciclo mensal ou envolve projeto específico solicitado pela Prefeitura ou pela direção da creche

Como saber o que já foi pago:

Conferência via comprovantes bancários da creche e registro manual em planilha da consultoria — ainda não automatizado, preciso revisar cada mês

CAPS II Renascer

Nome da instituição:

CAPS II Renascer

Tipo de instituição:

Centro de Atenção Psicossocial — serviço público municipal de saúde mental

Cidade:

São Luís, MA

Responsável principal:

Dr. Augusto Leal, 48 anos, psiquiatra e coordenador

Outros contatos:

Assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos de referência, equipe administrativa do CAPS

Telefone/WhatsApp:

Comunicação direta com o Dr. Augusto via WhatsApp profissional e grupo da equipe para avisos urgentes

Data de início do contrato:

2020 — acompanhamento contínuo desde então

Status do cliente:

Ativo

Nível de complexidade:

Alto — são cerca de 280 usuários, múltiplas modalidades de atendimento (intensivo, semi-intensivo, não-intensivo), registros separados por profissional, atendimentos individuais e em grupo, crise frequente fora do horário

Frequência de visitas:

Mensal, com possibilidade de visitas extras em situações de crise ou auditorias

Local de atendimento:

Presencial

Tipo de serviço prestado:

Diagnóstico organizacional, acompanhamento do registro de atendimentos, reuniões de equipe multiprofissional, conferência do Projeto Terapêutico Singular, relatórios para RAAS/DATASUS

Observações gerais:

O CAPS funciona em alta pressão: atendimentos abertos, crises noturnas, registro de cada usuário é coletivo e individual. Projetos terapêuticos em papel, equipes distintas registrando informações separadas, famílias participam em grupos. Alterações de modalidade de atendimento nem sempre são registradas formalmente

Tipo de contrato:

Mensal, baseado em acompanhamento contínuo e relatórios periódicos

Quantidade de visitas previstas:

1 visita mensal programada, mais visitas extras conforme necessidade (crises ou auditorias)

Inclui relatório?

Sim — relatórios de produtividade, crises atendidas, usuários ausentes e indicadores de equipe

Data de término do contrato:

Indefinido, renovação automática mensal

Valor acordado / forma de pagamento:

Valor fixo mensal negociado com a coordenação do CAPS, pago via repasse institucional ou convênio com a prefeitura

Pode ter alteração? Como acontece?

Sim, ajustes são feitos se houver aumento significativo de usuários ou necessidade de projeto especial, negociado diretamente com Dr. Augusto

Inclui visitas extras?

Sim, visitas emergenciais ou para situações críticas de usuários, planejamento de novos grupos terapêuticos ou auditorias institucionais

Como identificar cobrança extra:

Qualquer visita que não esteja prevista no ciclo mensal ou envolva projeto especial solicitado pelo CAPS ou pela Secretaria de Saúde

Como saber o que já foi pago:

Conferência via comprovantes da Prefeitura ou repasses institucionais e registro em planilha de controle da consultoria, ainda manual

CuidaBem

Nome da instituição:

CuidaBem

Tipo de instituição:

Empresa privada de home care — modelo de plataforma

Cidade:

São Luís, MA

Responsável principal:

Marcela Viana, 38 anos, enfermeira e fundadora

Outros contatos:

Cuidadores cadastrados (CLT e autônomos), famílias atendidas, equipe de suporte administrativo da CuidaBem

Telefone/WhatsApp:

Contato principal via WhatsApp da Marcela e grupos de cuidadores para escala e emergências

Data de início do contrato:

2021 — acompanhamento contínuo desde o início da operação da plataforma

Status do cliente:

Ativo

Nível de complexidade:

Alto — 45 cuidadores atendendo ~90 famílias com horários variados, substituições frequentes e necessidade de acompanhar formação e certificação de cada profissional

Frequência de visitas:

Mensal, com acompanhamento contínuo remoto e visitas extras sob demanda

Local de atendimento:

Híbrido — parte presencial para avaliação e reuniões, parte remoto via comunicação digital

Tipo de serviço prestado:

Diagnóstico organizacional, acompanhamento de escalas e turnos de cuidadores, reuniões com Marcela e avaliação de processos, relatórios sobre horas trabalhadas, certificações, avaliações das famílias

Observações gerais:

O sistema é manual: escala por WhatsApp e planilha. Um cuidador pode atender três residências diferentes numa semana. Substituições emergenciais geram confusão sobre quem cobriu quem, avaliações múltiplas de cuidadores e famílias não são centralizadas. Certificados vencidos podem impedir atendimento sem aviso prévio.

Tipo de contrato:

Mensal, baseado em acompanhamento contínuo, relatórios e suporte administrativo

Quantidade de visitas previstas:

1 visita presencial mensal, acompanhamento remoto contínuo e visitas extras conforme necessidade

Inclui relatório?

Sim — horas trabalhadas por cuidador, famílias com múltiplas trocas, certificados vencidos, média de avaliação dos cuidadores

Data de término do contrato:

Indefinido, renovação automática mensal

Valor acordado / forma de pagamento:

Valor fixo mensal negociado com Marcela, pago via transferência bancária

Pode ter alteração? Como acontece?

Sim, caso o número de cuidadores ou famílias aumente ou surja demanda extraordinária, ajustado via negociação direta com Marcela

Inclui visitas extras?

Sim, principalmente para emergências, treinamento de cuidadores ou auditoria de processos

Como identificar cobrança extra:

Visitas ou consultorias que não estavam previstas no ciclo mensal, incluindo situações emergenciais ou projetos específicos

Como saber o que já foi pago:

Registro em planilha de controle da consultoria e conferência de comprovantes bancários — ainda manual e exige revisão mensal

REABILITA

Nome da instituição:

REABILITA

Tipo de instituição:

Clínica privada de reabilitação física com convênio parcial SUS

Cidade:

São Luís, MA

Responsável principal:

Dra. Fernanda Caldas, 46 anos, fisioterapeuta e sócia-proprietária

Outros contatos:

Fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, equipe administrativa, recepção, pacientes particulares e SUS

Telefone/WhatsApp:

Contato direto com Dra. Fernanda via WhatsApp e telefone da clínica

Data de início do contrato:

2019 — acompanhamento contínuo desde então

Status do cliente:

Ativo

Nível de complexidade:

Alto — múltiplos pacientes, convênios diferentes (SUS e particular), planos de tratamento com metas, sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, necessidade de rastrear evolução clínica e laudos

Frequência de visitas:

Mensal, com visitas extras sob demanda para auditoria de sessões ou avaliação de planos de tratamento

Local de atendimento:

Presencial

Tipo de serviço prestado:

Diagnóstico organizacional, acompanhamento de evolução clínica por paciente, reuniões sobre planos de tratamento, conferência de sessões realizadas, elaboração de relatórios de desempenho e produtividade

Observações gerais:

Pacientes podem ter múltiplos procedimentos no mesmo dia, sessões SUS e particulares podem ocorrer juntas, planos de tratamento têm metas que nem sempre são registradas de forma padronizada, laudos finais exigem assinatura do responsável técnico. Cancelamentos e renovações de plano geram confusão no controle manual

Tipo de contrato:

Mensal, baseado em acompanhamento contínuo, relatórios e consultoria

Quantidade de visitas previstas:

1 visita presencial mensal, mais visitas extras conforme necessidade

Inclui relatório?

Sim — pacientes que atingiram metas, evolução clínica, taxa de ocupação das salas, procedimentos mais realizados, sessões sem evolução registrada

Data de término do contrato:

Indefinido, renovação automática mensal

Valor acordado / forma de pagamento:

Valor fixo mensal negociado com Dra. Fernanda, pago via transferência bancária

Pode ter alteração? Como acontece?

Sim, caso haja aumento de pacientes, necessidade de auditoria de convênios ou projetos especiais, negociado diretamente com Dra. Fernanda

Inclui visitas extras?

Sim — auditorias de sessões, avaliação de planos de tratamento, ajustes emergenciais de controle

Como identificar cobrança extra:

Visitas ou serviços que não estavam previstos no ciclo mensal ou envolvam projetos especiais solicitados pela clínica

Como saber o que já foi pago:

Conferência via comprovantes bancários e planilha de controle manual da consultoria

APAE de Bacabal

Nome da instituição:

APAE de Bacabal

Tipo de instituição:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais — entidade sem fins lucrativos

Cidade:

Bacabal, MA

Responsável principal:

Neuza Farias, 55 anos, diretora pedagógica

Outros contatos:

Professores, equipe administrativa, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, familiares de alunos/pacientes

Telefone/WhatsApp:

Contato direto via WhatsApp com a Neuza e grupo da equipe para assuntos operacionais

Data de início do contrato:

2020 — acompanhamento contínuo desde então

Status do cliente:

Ativo

Nível de complexidade:

Alto — triplo convênio (saúde, educação, assistência social), múltiplos programas, registro de PIA, metas de desenvolvimento, frequência de alunos, coordenação de oficinas e terapias

Frequência de visitas:

Mensal, com possibilidade de visitas extras conforme demanda ou auditoria de programas

Local de atendimento:

Presencial

Tipo de serviço prestado:

Diagnóstico organizacional, acompanhamento de planos individuais (PIA), reuniões com equipe multiprofissional, conferência de frequência e evolução de habilidades, relatórios para Censo Escolar e órgãos conveniados

Observações gerais:

O conhecimento sobre cada aluno está em grande parte na cabeça da Neuza; registros são em papel. Responsáveis legais podem mudar, adulto com deficiência intelectual precisa de autorização especial, histórico de alta pedagógica precisa ser preservado, oficinas produzem bens que geram receita mas o registro não é padronizado.

Tipo de contrato:

Mensal, baseado em acompanhamento contínuo e relatórios periódicos

Quantidade de visitas previstas:

1 visita mensal programada, mais visitas extras conforme necessidade

Inclui relatório?

Sim — evolução de habilidades, metas do PIA, frequência, relatórios para Censo Escolar e conveniados

Data de término do contrato:

Indefinido, renovação automática mensal

Valor acordado / forma de pagamento:

Valor fixo mensal negociado com Neuza, pago via transferência bancária

Pode ter alteração? Como acontece?

Sim, ajustes ocorrem quando há aumento de atendidos, novos programas ou demandas extraordinárias, negociado diretamente com Neuza

Inclui visitas extras?

Sim — visitas emergenciais, auditorias de programas ou acompanhamento de novas turmas ou oficinas

Como identificar cobrança extra:

Qualquer visita ou serviço que não esteja previsto no ciclo mensal, incluindo projetos especiais ou auditorias solicitadas pela direção

Como saber o que já foi pago:

Conferência em planilha de controle manual da consultoria e comprovantes bancários — revisão mensal necessária

FarmaVida

Nome da instituição:

FarmaVida

Tipo de instituição:

Farmácia popular comunitária — participante do Programa Farmácia Popular do Governo Federal

Cidade:

Caxias, MA

Responsável principal:

Raimundo Alves, 60 anos, proprietário

Outros contatos:

Equipe de atendimento da farmácia (4 funcionários), eventualmente farmacêuticos substitutos

Telefone/WhatsApp:

Contato direto com Raimundo via WhatsApp e telefone da farmácia

Data de início do contrato:

2019 — acompanhamento contínuo desde então

Status do cliente:

Ativo

Nível de complexidade:

Médio — controle de estoque, dispensação de medicamentos, registros de pacientes e prescrição, integração parcial com sistemas do governo

Frequência de visitas:

Mensal, com visitas extras sob demanda para auditoria de dispensação ou treinamento

Local de atendimento:

Presencial

Tipo de serviço prestado:

Diagnóstico organizacional, acompanhamento de estoque e dispensação, conferência de registros do Programa Farmácia Popular, reuniões de orientação e relatórios de controle

Observações gerais:

Raimundo conhece cada cliente e medicamento na ponta do lápis, mas registros estão em caderno e notas fiscais; precisa cumprir regras de rastreabilidade para subsídios federais; medicamentos controlados exigem registro rigoroso; estoque e prescrição não estão integrados a nenhum sistema interno

Tipo de contrato:

Mensal, baseado em acompanhamento contínuo e relatórios periódicos

Quantidade de visitas previstas:

1 visita mensal programada, mais visitas extras conforme necessidade

Inclui relatório?

Sim — controle de dispensação, estoque, medicamentos próximos do vencimento e utilização de subsídios federais

Data de término do contrato:

Indefinido, renovação automática mensal

Valor acordado / forma de pagamento:

Valor fixo mensal negociado com Raimundo, pago via transferência bancária

Pode ter alteração? Como acontece?

Sim, caso haja aumento de volume de dispensação, mudanças regulatórias ou auditorias extraordinárias, negociado diretamente com Raimundo

Inclui visitas extras?

Sim — auditorias de estoque, conferência de prescrição ou treinamento da equipe

Como identificar cobrança extra:

Qualquer visita ou serviço que não estava previsto no ciclo mensal, incluindo auditorias especiais ou treinamentos solicitados pelo proprietário

Como saber o que já foi pago:

Conferência em planilha de controle da consultoria e comprovantes bancários — ainda manual, exige revisão mensal

Histórico de cada cliente

Lar São Francisco

Atendimentos realizados: visitas mensais de acompanhamento, reuniões com Conceição e equipe de enfermagem, elaboração de relatórios trimestrais e anuais para VISA, auditorias internas de medicação e incidentes.

Diagnóstico inicial: feito em 2018 — apontou caos administrativo, prontuários espalhados em papéis, registro de medicação e incidentes desorganizado.

Pendências/tarefas: revisar sistema de controle de medicação, organizar histórico de incidentes de residentes, definir responsável legal para casos complexos.

Alterações significativas: nenhum grande ajuste no contrato, mas incluímos visitas emergenciais pontuais e relatórios extras quando houve problemas com substituição de médicos.

Eventos críticos: erro grave na administração de medicação quando o médico substituto não conseguiu acessar histórico; várias quedas de residentes registradas apenas em livro sem padronização.

Creche Sonho de Criança

Atendimentos realizados: visitas mensais, reuniões com Rosângela, relatórios de frequência e cardápio para a Prefeitura, auditorias pontuais de documentação de crianças e vacinação.

Diagnóstico inicial: 2019 — frequências e registros de alimentação totalmente manuais, histórico de crianças disperso, dificuldade de rastrear responsáveis legais.

Pendências/tarefas: atualização das listas de responsáveis, implementação de controle de frequência mais confiável, padronização de registros de alimentação e vacinação.

Alterações significativas: incluímos visitas extras para auditorias trimestrais solicitadas pela Prefeitura.

Eventos críticos: crianças com documentação incompleta permanecendo em listas por meses; dificuldade em auditar frequência por turma.

CAPS II Renascer

Atendimentos realizados: visitas mensais de acompanhamento, reuniões de equipe multiprofissional, conferência de Projetos Terapêuticos Singulares, relatórios mensais para RAAS/DATASUS, acompanhamento de crises fora do horário.

Diagnóstico inicial: 2020 — registros separados por profissional, alta demanda de atendimento, risco de perda de informações em caso de ausência de equipe.

Pendências/tarefas: monitorar usuários intensivos ausentes, registrar crises externas ao CAPS, consolidar histórico de mudança de modalidade de atendimento.

Alterações significativas: nenhuma mudança formal no contrato, mas incluímos acompanhamento emergencial de crises e relatórios de produtividade da equipe.

Eventos críticos: crises noturnas de usuários levados ao pronto-socorro sem registro formal; mudanças de modalidade sem documentação.

CuidaBem

Atendimentos realizados: visitas mensais presenciais, acompanhamento remoto diário, reuniões de escala e certificação de cuidadores, relatórios de horas trabalhadas, avaliação de famílias e cuidadores.

Diagnóstico inicial: 2021 — controle via WhatsApp e planilhas, substituições emergenciais não registradas, risco de cuidadores sem certificação atuando.

Pendências/tarefas: atualizar registros de horas de cada cuidador, checar validade de certificados, implementar histórico de substituições emergenciais.

Alterações significativas: ajustes na quantidade de visitas extras para emergências; maior detalhamento de relatórios de horas trabalhadas.

Eventos críticos: idoso ficou sem cuidador por 4 horas devido a falha na substituição; registros de avaliação das famílias e cuidadores não estavam centralizados.

REABILITA

Atendimentos realizados: visitas mensais, reuniões sobre evolução clínica, conferência de planos de tratamento, relatórios de pacientes e sessões, auditorias de sessões SUS e particulares.

Diagnóstico inicial: 2019 — múltiplos procedimentos por sessão, convênios coexistindo, dificuldade em monitorar metas de plano de tratamento.

Pendências/tarefas: verificar sessões sem evolução registrada, consolidar laudos finais, monitorar renovação de planos de tratamento.

Alterações significativas: inclusão de auditorias de sessões e relatórios mais detalhados por convênio.

Eventos críticos: paciente cancelou sessão de convênio sem aviso; dificuldade em consolidar evolução de fisioterapia e fonoaudiologia no mesmo prontuário.

APAE de Bacabal

Atendimentos realizados: visitas mensais, reuniões com Neuza e equipe, conferência de PIA, relatórios de evolução de habilidades, relatórios para Censo Escolar e órgãos conveniados.

Diagnóstico inicial: 2020 — conhecimento concentrado na diretora, registros em papel, triplo convênio complexo, histórico de alta pedagógica não padronizado.

Pendências/tarefas: digitalizar e centralizar PIA, acompanhar transições de alunos, registrar produção de oficinas e receitas associadas.

Alterações significativas: nenhum ajuste formal, mas acompanhamento de novos programas e oficinas incluído nas visitas extras.

Eventos críticos: possíveis lacunas no registro de autorização de adultos com deficiência intelectual; dificuldades em manter histórico de alunos que mudam de turma.

FarmaVida

Atendimentos realizados: visitas mensais, reuniões com Raimundo, conferência de estoque e dispensação, relatórios de medicamentos próximos do vencimento, auditorias de prescrição e subsídio federal.

Diagnóstico inicial: 2019 — registros em caderno, estoque separado de programa federal e particular, risco de perda de receita se registro falhar.

Pendências/tarefas: padronizar controle de dispensação, rastrear medicamentos de controle especial, revisar histórico de prescrição para subsídios.

Alterações significativas: visitas extras incluídas para auditorias especiais de estoque e treinamento de equipe.

Eventos críticos: risco de perda de subsídio federal devido a falhas na conferência de lotes ou dispensações múltiplas; substituições de medicamentos por genéricos sem registro formal.

Contatos de cada cliente

Lar São Francisco

Responsável principal: Conceição Ribeiro, diretora e enfermeira; coordena toda a operação e responde pela gestão do cuidado.

Outros contatos: filha da Conceição (administrativo/financeiro), equipe de enfermagem, médicos prestadores, nutricionista terceirizada.

Contato para emergências: Conceição ou, se não disponível, a filha dela no administrativo.

Padrão de comunicação: WhatsApp para urgências e troca rápida de informações; e-mails para relatórios e documentos formais.

Autonomia para decisões: Conceição decide sobre cuidado, pessoal e emergências; filha decide sobre pagamentos e contratos relacionados.

Creche Sonho de Criança

Responsável principal: Rosângela Teixeira, pedagoga e diretora; coordena operações diárias e supervisão pedagógica.

Outros contatos: secretária (frequência e documentação), professoras e auxiliares (registro de turmas), cozinheiras (cardápio), equipe administrativa.

Contato para emergências: Rosângela diretamente pelo WhatsApp; professora responsável em caso de incidentes durante o dia.

Padrão de comunicação: WhatsApp para emergências e avisos rápidos, e-mail para relatórios mensais e prestação de contas.

Autonomia para decisões: Rosângela toma decisões pedagógicas e operacionais; secretária e professores têm autonomia limitada para assuntos do dia a dia.

CAPS II Renascer

Responsável principal: Dr. Augusto Leal, psiquiatra e coordenador; toma decisões clínicas e coordena equipe.

Outros contatos: psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, técnicos de referência, equipe administrativa.

Contato para emergências: Dr. Augusto diretamente; equipe de referência para crises fora do horário.

Padrão de comunicação: WhatsApp para avisos urgentes, e-mail para relatórios e solicitações formais.

Autonomia para decisões: Dr. Augusto tem autonomia clínica e administrativa; outros profissionais decidem dentro de suas áreas de atuação (terapia, grupo, acompanhamento individual).

CuidaBem

Responsável principal: Marcela Viana, enfermeira e fundadora; coordena todos os cuidadores e famílias.

Outros contatos: cuidadores cadastrados, famílias atendidas, equipe de suporte administrativo da plataforma.

Contato para emergências: Marcela diretamente ou cuidador responsável via WhatsApp.

Padrão de comunicação: WhatsApp para escalas, trocas emergenciais e ocorrências; reuniões presenciais ou chamadas para decisões estratégicas.

Autonomia para decisões: Marcela decide sobre contratação, substituição e ajustes operacionais; cuidadores têm autonomia limitada no atendimento diário.

REABILITA

Responsável principal: Dra. Fernanda Caldas, fisioterapeuta e sócia-proprietária; coordena clínica, planos de tratamento e equipe.

Outros contatos: fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, recepção e equipe administrativa.

Contato para emergências: Dra. Fernanda diretamente; recepção pode acionar profissionais quando necessário.

Padrão de comunicação: WhatsApp para avisos rápidos, e-mail para relatórios de pacientes e planos de tratamento.

Autonomia para decisões: Dra. Fernanda toma decisões clínicas e financeiras; profissionais decidem sobre evolução e execução de sessões.

APAE de Bacabal

Responsável principal: Neuza Farias, diretora pedagógica; coordena programas e equipe multiprofissional.

Outros contatos: professores, equipe administrativa, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, familiares.

Contato para emergências: Neuza; professores ou familiares informam situações urgentes durante atividades.

Padrão de comunicação: WhatsApp para urgências e mensagens rápidas, e-mail para relatórios e documentos oficiais.

Autonomia para decisões: Neuza decide sobre programas, PIA e operações; professores decidem sobre atividades diárias e acompanhamento pedagógico.

FarmaVida

Responsável principal: Raimundo Alves, proprietário; controla operações e dispensação de medicamentos.

Outros contatos: equipe de atendimento da farmácia, eventualmente farmacêuticos substitutos.

Contato para emergências: Raimundo diretamente.

Padrão de comunicação: WhatsApp para avisos urgentes, presencial para conferência de estoque, e-mail para relatórios ou prestação de contas.

Autonomia para decisões: Raimundo decide tudo na farmácia — estoque, dispensação e financeiro; funcionários seguem orientação direta.

Preferências e particularidades de
cada cliente

Lar São Francisco

Requisitos ou regras especiais: todo registro de medicação e incidentes precisa ser conferido com cuidado; respeitar rotinas de alimentação e cuidados dos residentes.

Limitações/Restrições: visitas preferencialmente durante horário administrativo; evitar atrapalhar horários de medicação.

Preferências de relatórios/comunicação: relatórios trimestrais e anuais detalhados, enviados por e-mail; WhatsApp apenas para emergências.

Particularidades com familiares/equipe: saber quem é realmente o responsável legal do residente; algumas decisões financeiras passam pela filha, outras pela Conceição.

Lembrete constante: conferir histórico completo de cada residente antes de qualquer visita; identificar se houve incidentes recentes.

Creche Sonho de Criança

Requisitos ou regras especiais: todos os registros de frequência e alimentação precisam estar completos; checar vacinação.

Limitações/Restrições: visitas não devem coincidir com horários de alimentação ou recreio; auditorias são agendadas com antecedência pela Rosângela.

Preferências de relatórios/comunicação: relatórios mensais via e-mail; WhatsApp para avisos urgentes.

Particularidades com familiares/equipe: responsáveis podem mudar com frequência (pais, avós); registrar mudanças de turma e saída de crianças.

Lembrete constante: conferir lista de crianças com documentação incompleta antes de cada visita; observar se alguma criança mudou de turma recentemente.

CAPS II Renascer

Requisitos ou regras especiais: registro do Projeto Terapêutico Singular precisa ser atualizado; observar mudanças de modalidade de atendimento.

Limitações/Restrições: visitas preferencialmente fora de horários de atendimento intensivo; acompanhar reuniões de equipe já agendadas.

Preferências de relatórios/comunicação: relatórios mensais detalhando usuários ausentes, crises externas e produtividade; WhatsApp para avisos de crise.

Particularidades com familiares/equipe: família participa de grupos terapêuticos; atenção à documentação individual x coletiva.

Lembrete constante: sempre conferir se todos os atendimentos da equipe foram registrados corretamente; anotar crises ocorridas fora do CAPS.

CuidaBem

Requisitos ou regras especiais: checar validade de certificados dos cuidadores, registrar substituições emergenciais.

Limitações/Restrições: visitas presenciais preferencialmente fora do horário de pico de atendimento domiciliar; acompanhamentos remotos diários.

Preferências de relatórios/comunicação: WhatsApp para escalas e ocorrências rápidas; relatórios mensais de horas trabalhadas e avaliações.

Particularidades com familiares/equipe: cada cuidador pode ter múltiplas famílias; familiares avaliam cuidadores e vice-versa.

Lembrete constante: confirmar se cada idoso tem cuidador titular disponível; verificar se todas as substituições foram registradas.

REABILITA

Requisitos ou regras especiais: cada sessão precisa ter evolução registrada; planos de tratamento devem ter metas mensuráveis.

Limitações/Restrições: visitas devem respeitar horários de atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia; sessões agendadas não podem ser interrompidas.

Preferências de relatórios/comunicação: relatórios mensais por paciente e convênio; WhatsApp para avisos de alterações emergenciais.

Particularidades com familiares/equipe: pacientes podem ter sessões SUS e particulares no mesmo dia; evolução precisa ser consolidada entre fisioterapia e fonoaudiologia.

Lembrete constante: checar se todas as sessões foram registradas corretamente e se há metas pendentes.

APAE de Bacabal

Requisitos ou regras especiais: acompanhar PIA de cada aluno, metas de habilidades e relatórios para Censo Escolar.

Limitações/Restrições: visitas preferencialmente durante horário escolar; respeitar atividades pedagógicas.

Preferências de relatórios/comunicação: WhatsApp para urgências; relatórios mensais para órgãos conveniados e planejamento de turmas.

Particularidades com familiares/equipe: tutores e responsáveis legais variam; alunos com deficiência intelectual podem precisar de autorização especial.

Lembrete constante: conferir planos individuais de cada aluno antes da visita e observar se houve alta pedagógica ou transição de turma.

FarmaVida

Requisitos ou regras especiais: controle rigoroso de estoque, dispensação de medicamentos e registro de lotes; cumprimento das regras do Programa Farmácia Popular.

Limitações/Restrições: visitas preferencialmente fora do horário de maior movimento; conferências detalhadas precisam de tempo sem atender clientes.

Preferências de relatórios/comunicação: relatórios de estoque e dispensação enviados por e-mail; WhatsApp para avisos urgentes sobre lotes ou prescrição.

Particularidades com familiares/equipe: cliente individual (paciente) precisa ser conferido por CPF; substituição de genéricos deve ser registrada.

Lembrete constante: verificar se todos os medicamentos próximos do vencimento estão registrados e se a dispensação do Programa Farmácia Popular foi correta.

Riscos e complexidade operacional

Lar São Francisco

Maiores desafios/risco: registro de medicação descentralizado, prontuários em papel, risco de erro em incidentes e alta complexidade de residentes com demência.

Situação recorrente que exige supervisão: conferência semanal de medicação e kardex de todos os 60 residentes.

Dependência de terceiros: médicos prestadores e nutricionista terceirizada, que usam sistemas próprios; qualquer falha impacta diretamente o cuidado.

Histórico de incidentes críticos: erro grave na administração de medicação quando o substituto do Dr. Álvaro não tinha acesso ao histórico; quedas de residentes não registradas corretamente.

Creche Sonho de Criança

Maiores desafios/risco: frequência manual impossível de auditar, registro de cardápio e vacinação em papel, responsáveis legais múltiplos e rotativos.

Situação recorrente que exige supervisão: conferência mensal de frequência e documentação das crianças antes de gerar relatório para a Prefeitura.

Dependência de terceiros: Prefeitura que fornece repasse e exige auditorias; atraso ou falta de documentação impacta repasses.

Histórico de incidentes críticos: crianças com documentação incompleta permanecendo em listas por meses, registro de frequência com erros.

CAPS II Renascer

Maiores desafios/risco: registro coletivo x individual, mudanças de modalidade sem documentação, crise fora do horário.

Situação recorrente que exige supervisão: verificar todos os Projetos Terapêuticos Singulares e registros de grupos semanais antes da visita.

Dependência de terceiros: equipe multiprofissional; ausência de qualquer profissional pode comprometer acompanhamento de usuários.

Histórico de incidentes críticos: crises noturnas de usuários que vão ao pronto-socorro sem registro formal, dificuldade em consolidar histórico de atendimentos.

CuidaBem

Maiores desafios/risco: escala complexa de cuidadores, substituições emergenciais, registros manuais em planilha/WhatsApp, certificados vencidos.

Situação recorrente que exige supervisão: garantir que idosos não fiquem sem cuidador e que todas as substituições sejam registradas.

Dependência de terceiros: cuidadores autônomos e CLT, cada um com disponibilidade variável; falha impacta atendimento.

Histórico de incidentes críticos: idoso ficou 4 horas sem cuidador por falha na substituição; dificuldade em consolidar avaliação de cuidadores e famílias.

REABILITA

Maiores desafios/risco: múltiplos procedimentos por sessão, convênios SUS e particulares simultâneos, plano de tratamento com metas não padronizadas.

Situação recorrente que exige supervisão: conferir evolução clínica e sessões realizadas; monitorar metas do plano de tratamento.

Dependência de terceiros: pacientes que usam SUS e particular; autorização de convênios para procedimentos.

Histórico de incidentes críticos: sessões canceladas sem registro, dificuldade em consolidar evolução de fisioterapia e fonoaudiologia.

APAE de Bacabal

Maiores desafios/risco: triplo convênio (saúde, educação, assistência), registro em papel, PIA e metas individuais, alterações de responsáveis legais.

Situação recorrente que exige supervisão: checar PIA e evolução de habilidades antes de cada visita.

Dependência de terceiros: professores, terapeutas, familiares para autorizações; falha em qualquer frente impacta acompanhamento.

Histórico de incidentes críticos: riscos em autorização de adultos com deficiência intelectual; histórico de alta pedagógica não centralizado.

FarmaVida

Maiores desafios/risco: controle de estoque, dispensação de medicamentos, rastreabilidade para subsídio federal, duplicidade de cadastros.

Situação recorrente que exige supervisão: conferir lotes e dispensação correta, atualizar medicamentos próximos do vencimento.

Dependência de terceiros: Sistema do Governo para Farmácia Popular; falhas impactam repasse e faturamento.

Histórico de incidentes críticos: risco de perda de subsídio federal; substituição de medicamentos sem registro adequado.

Métricas e acompanhamento

Lar São Francisco

Indicadores: número de visitas mensais realizadas, pendências por residente, relatórios entregues à VISA, incidentes por trimestre, taxa de medicação conferida corretamente.

Prazos/metast: relatórios trimestrais e anuais entregues no prazo; incidentes revisados semanalmente; garantir que todos os residentes tenham histórico atualizado antes da visita.

Registro/medição: atualmente em planilhas e cadernos; gostaria de acompanhar evolução por residente em uma ferramenta que centralize medicação, incidentes e histórico de saúde.

Creche Sonho de Criança

Indicadores: frequência diária de cada criança, número de relatórios entregues à Prefeitura, pendências de documentação ou vacinação, incidência de faltas acima de 25%.

Prazos/metast: relatórios mensais enviados; frequência mínima de 75% por criança; atualização de documentação antes do fechamento de cada mês.

Registro/medição: atualmente manual em caderno e planilhas; gostaria de ter dashboard que mostrasse crianças em risco de frequência insuficiente e pendências documentais.

CAPS II Renascer

Indicadores: número de atendimentos individuais e em grupo registrados, crises externas registradas, usuários ausentes há mais de 15 dias, relatórios de produtividade da equipe.

Prazos/metast: relatórios mensais para RAAS/DATASUS; acompanhamento semanal de usuários intensivos e crises.

Registro/medição: atualmente em papel e planilhas; gostaria de consolidar atendimentos, crises e produtividade da equipe em um painel único.

CuidaBem

Indicadores: horas trabalhadas por cuidador, número de substituições emergenciais, famílias com mais de 3 trocas de cuidador em 6 meses, certificados de cuidadores vencidos.

Prazos/metast: atualização mensal de certificados; garantir que nenhum idoso fique sem cuidador titular mais de 15 dias; relatórios mensais para Marcela.

Registro/medição: atualmente via planilha e WhatsApp; ideal seria plataforma que rastreasse escalas, substituições e certificações automaticamente.

REABILITA

Indicadores: número de sessões realizadas por paciente, evolução clínica por meta do plano de tratamento, laudos entregues, taxa de ocupação das salas, procedimentos mais realizados.

Prazos/metast: laudos entregues ao final de cada plano; evolução de metas monitorada ao longo das sessões; relatórios mensais consolidados por convênio.

Registro/medição: atualmente em planilhas e prontuários de papel; desejável rastrear evolução clínica e metas de forma centralizada.

APAE de Bacabal

Indicadores: frequência por programa e turno, metas do PIA atingidas, relatórios para Censo Escolar e conveniados, número de alunos em transição para vida adulta.

Prazos/metast: relatórios semestrais de evolução; atualização do PIA a cada 6 meses; frequência mínima por programa.

Registro/medição: atualmente em papel; gostaria de digitalizar PIA e consolidar evolução de habilidades e frequência em um sistema único.

FarmaVida

Indicadores: medicamentos dispensados por lote, estoque disponível, medicamentos próximos do vencimento, total de subsídio federal utilizado, pacientes de uso contínuo que não retiraram medicamento há mais de 45 dias.

Prazos/metast: conferência mensal de estoque e dispensação; relatórios mensais para controle de subsídios; evitar perdas financeiras.

Registro/medição: atualmente em caderno e notas fiscais; ideal seria integração com sistema de dispensação e rastreabilidade de estoque.

Preferências de cobrança e financeiro

Olha, vamos detalhar cliente por cliente porque cada um tem uma situação bem diferente em relação a pagamento e cobrança. No Lar São Francisco, por exemplo, a regra de cobrança extra não é muito clara — o que eles pagam é a mensalidade que varia de R\$ 3.200 a R\$ 5.800, dependendo do grau de dependência do idoso. Se tiver algum serviço pontual fora do contrato, tipo fisioterapia extra ou exames, a aprovação de valores normalmente passa pela Conceição ou pela filha dela, que cuida do administrativo. Já houve casos de famílias atrasarem pagamento, principalmente as conveniadas pelo município, e às vezes rola uma negociação “informal” de desconto ou parcelamento. Eu queria poder acompanhar de forma simples: um quadro único com valor contratado, pagos, pendentes e qualquer extra, sem precisar procurar no WhatsApp ou no caderno por horas.

Na Creche Sonho de Criança, a regra é mais institucional: a Prefeitura paga R\$ 480/mês por criança, e qualquer cobrança extra depende de aprovação da Rosângela. Aqui, atrasos são raros porque é repasse público, mas já houve negociações quando famílias entram ou saem no meio do ano, ou não cumprem a frequência mínima exigida. Um histórico consolidado de pagamentos, vinculando cada criança à mensalidade, à frequência e às pendências, seria o ideal para não depender de caderno ou planilhas separadas.

O CAPS II Renascer é público, então não há cobrança direta — mas se houver algum serviço ou projeto especial que precise de custo, a aprovação depende do Dr. Augusto. Não há atrasos de pagamento, mas há complexidade: cada atendimento pode ter financiamento diferente, e às vezes precisamos controlar horas de parceiros ou especialistas em projetos pagos separadamente. Eu queria registrar tudo de forma que eu consiga ver, por usuário ou projeto, o que já foi custeado, o que ainda depende de liberação e se houve ajustes.

O CuidaBem é um caso complicado porque cada família paga por hora de cuidado. Existe regra clara de cobrança extra: se precisar de atendimento fora do plano contratado, a Marcela aprova e ajusta valor. Atrasos acontecem quando famílias demoram a pagar no início do mês, e já houve negociação para remarcar horas ou substituir cuidadores sem custo extra. Aqui, um painel mostrando horas contratadas, usadas, extras e pendentes seria ouro — não precisa olhar planilhas separadas nem WhatsApp.

Na REABILITA, cada sessão particular tem cobrança própria, e convênios SUS têm regras específicas. A Dra. Fernanda aprova mudanças de valores ou visitas extras. Já tive paciente que cancelou sessões e negociou pagamento parcial — isso precisa estar registrado. Um sistema que mostre sessões pagas, pendentes e extras, com evolução clínica, seria essencial.

Na APAE de Bacabal, a regra de cobrança é mais complexa: há repasses do SUS, Prefeitura e SUAS, e qualquer ajuste ou serviço extra precisa da aprovação da Neuza. Atrasos ou renegociações são frequentes, porque cada fonte de financiamento tem calendário diferente. Um quadro que consolide todos os repasses e valores extras por pessoa atendida ajudaria muito.

Por fim, na FarmaVida, os pagamentos particulares são simples, mas o reembolso do Farmácia Popular exige controle exato. Qualquer venda extra ou fora do programa precisa da aprovação do Raimundo. Já houve atrasos por erro de registro e ele precisa acompanhar valores pagos, pendentes e subsídios federais usados.

Outras perguntas

Olha, vamos por partes porque cada ponto tem uma implicação prática pro meu dia a dia. Sobre identificadores únicos, eu nunca usei CNPJs ou CPFs de forma sistemática — na prática, eu lembro do cliente pelo nome ou pelo contato principal. Para contatos individuais, às vezes eu tenho e-mail, às vezes só telefone. Por exemplo, no CAPS, o contato é o Dr. Augusto, mas às vezes quem me liga é a assistente social; no Lar São Francisco, a Conceição é o contato principal, mas decisões financeiras passam pela filha dela. Então, não tenho um registro único confiável hoje — por isso é que quero algo que ajude a diferenciar sem depender só da memória.

Quanto ao histórico de contratos, eu vejo como importante guardar valores antigos. Já aconteceu do Lar São Francisco aumentar a mensalidade de alguns residentes ou a APAE ter ajuste no repasse, e se eu não tiver histórico, eu perco a referência de quanto estava sendo cobrado antes. Mas também quero que o sistema mostre o valor atual de forma clara, sem precisar buscar entre várias anotações antigas.

3: Sobre cálculo variável de mensalidade, olha, no Lar São Francisco seria útil sim que o sistema calculasse automaticamente com base no grau de dependência de cada residente — mas não precisa ser perfeito, um campo para registrar manualmente o valor total do mês também serve. Na prática, a rotina de ajuste é feita uma vez por mês, então até consigo lidar com manual se for mais simples.

4: E pendências de visita... eu não quero só marcar “Resolvido/Não Resolvido”. Preciso ter um espaço para detalhar o que foi feito — por exemplo, se a visita ao CAPS resultou em encaminhamento para especialista ou se no Lar São Francisco tivemos que reorganizar a escala de enfermagem por causa de um incidente. Isso me ajuda a lembrar o que aconteceu sem ter que ligar para o cliente ou buscar no caderno.

Excelente trabalho de campo! Você acabou de viver o dia a dia de um Analista de Sistemas Sênior. O cliente raramente sabe o que quer em termos técnicos, mas ele sabe perfeitamente o que precisa na prática.

Como hoje é sexta-feira, nosso dia de aprofundamento, vamos traduzir as respostas do Adriano para a linguagem de Modelagem de Dados (a sua UA II). Veja como cada resposta dele define o desenho do nosso banco:

RESPOSTA DA GI:  Traduzindo as Respostas para o Banco de Dados

1. O problema do CNPJ/CPF (A Chave Primária):

A Dor: Ele não tem o CNPJ ou CPF de todo mundo anotado.

A Solução Técnica: Não poderemos usar uma "Chave Natural" (dados do mundo real, como CPF) como identificador único. Teremos que usar uma Chave Artificial (Surrogate Key). O seu banco de dados terá que gerar automaticamente um id_cliente (1, 2, 3...) e um id_contato (1, 2, 3...).

2. O Histórico de Contratos:

A Dor: Ele precisa ver os valores antigos, mas quer facilidade para ver o atual.

A Solução Técnica: Acabamos de confirmar que a relação entre Cliente e Contrato é 1:N. O cliente "Lar São Francisco" terá vários registros na tabela de Contratos. Para ele ver só o atual rápido, usaremos um campo status_contrato (Ativo/Inativo) ou filtraremos pela data_fim mais recente usando SQL na sua UA III.

3. O Cálculo Variável (Fugindo da armadilha):

A Dor: Ele achou legal calcular os idosos, mas aceita digitar o valor manual.

A Solução Técnica: Vitória do Analista! Se você tentasse calcular o grau de dependência de cada idoso, você teria que criar tabelas de Paciente, Grau_Dependencia, etc. Isso se chama Scope Creep (quando o projeto incha e foge do controle). O sistema é para a consultoria dele, não para gerenciar a clínica. Vamos manter um campo de valor_total_mensal manual na tabela de Faturamento/Contrato.

4. O Detalhamento das Pendências:

A Dor: Um "Resolvido" (Sim/Não) não basta. Ele precisa da história.

A Solução Técnica: Na entidade Visita (ou Pendencia), além do atributo booleano de status, teremos que incluir um atributo descricao_resolucao do tipo TEXT ou VARCHAR(500) para ele escrever a fofoca toda (ex: "encaminhado para especialista").

Respostas da Gi

Parte 1: Proposta de Texto para o Relatório:

"O Adriano Matos é um administrador de 47 anos que, desde 2014, dirige a **AM Consultoria**, uma empresa maranhense especializada em organizar a gestão de instituições voltadas à saúde, assistência e educação especial. Na prática, ele atua como um 'organizador de casas': ele entra em organizações como o **CAPS II Renascer**, o **Lar São Francisco** e a **APAE de Bacabal**, identifica gargalos operacionais, cria planos de ação e treina equipes para que o cuidado com as pessoas seja eficiente.

O problema real que ele enfrenta é o **colapso da autogestão por excesso de demanda**. Adriano cresceu, mas suas ferramentas de controle continuam artesanais. Atualmente, ele gerencia **7 clientes complexos sozinho** (após a saída de sua assistente há dois meses), o que resultou em uma fragmentação crítica de informações. Os dados estão espalhados em cadernos, conversas de WhatsApp e na memória. Isso causa sintomas graves no negócio, como levar **20 minutos para localizar uma data de visita**, esquecer pendências técnicas de pacientes antes de reuniões com médicos e perder o controle financeiro, já que cada contrato possui regras de faturamento distintas que ele não consegue consolidar rapidamente.

Isso é vital para a **Economia do Cuidado** porque o trabalho do Adriano sustenta instituições que lidam com vidas vulneráveis (idosos, crianças e pacientes psiquiátricos). No contexto de um Maranhão que envelhece rapidamente, a desorganização da consultoria gera um efeito cascata: se o consultor falha em organizar o processo do Lar São Francisco ou do CAPS, a qualidade do atendimento direto ao assistido cai. Organizar a AM Consultoria não é apenas uma questão de eficiência empresarial, é garantir a sustentabilidade de serviços essenciais que protegem a vida."

Parte 1 Concisa

1. O CLIENTE E O SEU MUNDO (Versão Sintetizada)

Apresentação do cliente e do problema central:

"Adriano Matos dirige a **AM Consultoria**, focada em organizar instituições da Economia do Cuidado no Maranhão (como o CAPS II e a APAE). Ele atua no

diagnóstico e ajuste de processos internos. O problema real é o **colapso da autogestão**: operando sozinho com **7 clientes simultâneos**, Adriano perdeu o controle dos dados, que estão fragmentados entre WhatsApp e cadernos. Isso causa atrasos em relatórios, perda de autoridade técnica e descontrole financeiro sobre o faturamento dos contratos."

Por que é importante para a Economia do Cuidado?

"Porque a desorganização da consultoria impacta diretamente a qualidade do atendimento a idosos, crianças e pacientes de saúde mental. Num cenário onde o Maranhão envelhece rápido, a eficiência na gestão destas instituições é o que garante a continuidade e a segurança do cuidado prestado aos vulneráveis."

Trecho ou situação marcante da conversa:

"Teve um dia que eu fui pro CAPS II Renascer. Cheguei lá... e me deu um branco. Eu não lembrava exatamente o que tinha ficado pendente da última visita. Eu tive que, antes de entrar, ligar pro próprio Dr. Augusto pra perguntar: 'Doutor, o que foi que a gente combinou da última vez mesmo?'. Na prática, eu perdi autoridade ali como consultor."

2. O QUE O GRUPO DESCOBRIU

Campo: Descobertas que surpreenderam o grupo durante a imersão

"O grupo descobriu que o problema do Adriano é a **heterogeneidade semântica e operacional**. Surpreendeu o fato de que cada cliente 'fala uma língua' diferente: no CAPS são 'usuários' e 'atendimentos', enquanto na CuidaBem são 'escalas de cuidadores' e 'plantões'. Outra descoberta crítica foi que a **'unidade de trabalho' (visita) não é padronizada**: uma visita pode durar 1 hora para resolver uma urgência ou um dia inteiro para um diagnóstico, mas no registro manual tudo é tratado como igual. Além disso, descobrimos que o fluxo de decisão nos clientes é confuso (ex: no CAPS o contato é o Dr. Augusto, mas a demanda vem da equipe; no

Lar, a diretora decide, mas a família paga), o que torna a gestão de stakeholders um desafio maior que a própria agenda."

Campo: Ambiguidade principal e como o grupo a resolveu

"A maior ambiguidade encontrada foi a **definição do que constitui uma 'Visita'**. Para o Adriano, 'visita' é um termo guarda-chuva que abriga reuniões, intervenções, acompanhamentos e crises, cada um com impactos financeiros e de tempo distintos.

Como o grupo resolveu: No modelo de dados, decidimos não criar tabelas separadas para cada tipo de evento (o que tornaria o sistema rígido), mas sim uma entidade central de 'Registro de Atendimento' com um atributo de '**Tipo de Atendimento**' (**Metadado**). Isso permite que o Adriano categorize a natureza da visita (se é cobrada à parte ou inclusa no contrato) sem perder a simplicidade que ele exige para usar a ferramenta no dia a dia."

Parte 2 Concisa: 2. O QUE O GRUPO DESCOBRIU

Descobertas que surpreenderam o grupo durante a imersão:

"A imersão revelou que o Adriano lida com **heterogeneidade semântica e operacional**: cada cliente possui um 'vocabulário' (usuário vs. paciente) e lógicas de gestão distintas (escalas de plantão vs. atendimentos clínicos). Surpreendeu o facto de que as **visitas não são padronizadas** (podem ser urgências de 1h ou diagnósticos de 8h), mas no papel são tratadas como iguais. Além disso, a gestão de **stakeholders** é complexa: ele precisa de reportar a diferentes responsáveis (médicos, diretores ou famílias) dependendo do cliente."

Ambiguidade principal e como o grupo a resolveu:

"A maior ambiguidade é a definição do que constitui uma '**Visita**', que hoje serve como um termo genérico para reuniões, intervenções e crises com pesos financeiros diferentes.

Resolução: Decidimos tratar a Visita como uma entidade central com um atributo de '**Categoria/Tipo**'. Em vez de tabelas rígidas para cada evento, usaremos este metadado para permitir flexibilidade no registro das variações sem aumentar a complexidade de uso para o Adriano."

3. CONEXÃO COM A ECONOMIA DO CUIDADO

Como o negócio analisado se insere na Economia do Cuidado

A AM Consultoria atua na infraestrutura de gestão do setor, operando sob a lógica de "cuidar de quem cuida". Embora não preste o atendimento clínico direto, o negócio garante a eficiência e a sobrevivência de instituições essenciais (como CAPS, APAEs e lares de idosos) que sustentam o bem-estar de pessoas vulneráveis. O projeto se conecta ao tema da UNDB ao propor **inovação** (sistematização de dados em substituição a cadernos e WhatsApp), **desenvolvimento** (permitindo que o consultor atenda mais clínicas sem perder qualidade) e **sustentabilidade** (evitando o colapso operacional da rede de assistência, criando um modelo que pode ser replicado para outras organizações).

Dado ou estatística encontrada

Segundo os dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE, a população idosa do Maranhão cresceu 44,53% em relação a 2010, alcançando mais de 821 mil pessoas (12,1% da população do estado). Projeções indicam que esse número continuará subindo rapidamente nas próximas décadas.

Fonte e como se relaciona com o negócio analisado

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Resultados do Censo 2022. **Relação com o negócio:** O envelhecimento acelerado da população maranhense gera uma explosão na demanda por instituições de cuidado (como o Lar São Francisco, cliente do Adriano). Atualmente, a desorganização da AM Consultoria atua como um "gargalo" que impede a evolução dessas clínicas. Implementar um Banco de Dados não resolve apenas a agenda do consultor, mas

fornece a infraestrutura tecnológica necessária para que a rede de cuidados do Maranhão suporte essa nova realidade demográfica com profissionalismo e segurança.

4. O MODELO DE DADOS E O IMPACTO ESPERADO

Descrição das principais entidades, relacionamentos e decisões de modelagem

O modelo foi desenhado com foco estrito na gestão operacional da AM Consultoria, evitando o *Scope Creep* (não será um ERP clínico para gerir alunos ou medicamentos). As principais entidades propostas são:

1. Cliente (Instituição): Entidade base com atributos estáticos (Nome, Tipo [ILPI, CAPS, Creche], Nível de Complexidade).

2. Contato (Relacionamento 1:N com Cliente): Separado do cadastro de cliente para suportar múltiplos interlocutores (ex: no Lar São Francisco, a Conceição é a gestora, mas a filha é o financeiro).

3. Contrato (Relacionamento 1:N com Cliente): Armazena a regra financeira atual e o histórico (Tipo de Cobrança, Valor Total). Decidimos não modelar variáveis internas dos clientes (como calcular o grau de dependência dos idosos) para manter o sistema flexível e simples, usando um campo de valor consolidado.

4. Visita/Atendimento (Relacionamento 1:N com Cliente): É a entidade transacional central. Possui a Data, um campo de texto rico para **Pendências/Historico** (para absorver a diversidade técnica de cada clínica sem criar tabelas específicas) e um atributo booleano (**is_extra**) para automatizar o rastreio de faturamentos avulsos.

Impacto esperado do sistema para o negócio e para o setor do cuidado

Para o Negócio (AM Consultoria): O sistema cria uma Fonte Única de Verdade (*Single Source of Truth*), eliminando a dependência de cadernos e do WhatsApp. Isso resolve o "apagão de memória" antes das reuniões (devolvendo a autoridade

técnica ao consultor) e estanca a perda financeira no fim do mês, pois o cruzamento automático das **Visitas Extras** com os **Contratos** dirá exatamente quanto cobrar de cada cliente.

Para o Setor do Cuidado: Reduz drasticamente o risco social. Falhas de gestão do consultor já deixaram idosos sem cuidadores (CuidaBem) e geraram riscos de medicação (Lar São Francisco). A sistematização garante que o Adriano atue de forma preditiva e segura, fortalecendo a infraestrutura de clínicas que sustentam vidas vulneráveis no Maranhão.

5. REFLEXÃO DO GRUPO

O que é mais difícil neste projeto? O que o grupo faria diferente se começasse de novo?

"A maior dificuldade foi delimitar a fronteira do sistema e evitar o *Scope Creep* (inchaço do escopo). Como cada cliente do Adriano atua de forma muito específica (controlando remédios no convênio, frequência de crianças ou planos terapêuticos), foi desafiador separar o que é a gestão da AM Consultoria do que é a operação interna das clínicas. Se começássemos de novo, focaríamos desde a primeira entrevista em mapear estritamente os processos do consultor, alinhando rapidamente que o sistema não tentaria absorver as complexidades operacionais e de estoque dos clientes finais."

Como esta experiência conecta banco de dados com questões sociais reais? O que essa conexão muda na forma como o grupo enxerga a disciplina?

"A experiência revelou que a modelagem de dados tem impacto humano direto. Quando a gestão de dados do Adriano falha (por depender da memória ou do WhatsApp), as consequências recaem sobre pessoas vulneráveis na ponta da Economia do Cuidado — resultando em idosos desassistidos por falha de escala ou perda de histórico de incidentes médicos. Isso muda a nossa visão da disciplina: Banco de Dados não é apenas sobre armazenar informações e criar tabelas com SQL, mas sobre projetar uma infraestrutura lógica que garante a segurança, a continuidade e a dignidade do cuidado na sociedade."

